

ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA HỆ
NGOẠI

Chăm sóc người bệnh Viêm xoang

Trường Cao đẳng Y tế Đắk
Lắk

Sinh viên thực hiện: **Phạm Thị Bích Hương**

Mã sinh viên: 24CD01044

Lớp: Cao Đẳng Điều Dưỡng

MỤC TIÊU BÀI HỌC



Kiến thức

- Giải thích được khái niệm và cơ chế bệnh sinh của viêm xoang.
- Trình bày đầy đủ triệu chứng lâm sàng & thực thể của từng nhóm xoang.
- Nêu được các biến chứng nguy hiểm và hướng điều trị cơ bản.



Kỹ năng

- Lập kế hoạch chăm sóc chi tiết cho người bệnh viêm xoang cấp/mãn.
- Thực hiện đúng quy trình rửa mũi bằng NaCl 0.9% và xông mũi.
- Hướng dẫn người bệnh kỹ thuật tự chăm sóc tại nhà.



Thái độ

- Tỉ mỉ, thận trọng trong quá trình thăm khám và chăm sóc.
- Ăn, uống, nghỉ ngơi đầy đủ và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ.
- Luôn phát hiện sớm các biến chứng để xử lý kịp thời.

1 ĐẠI CƯƠNG & GIẢI PHẪU

1.1 Khái niệm

Là tình trạng viêm lớp niêm mạc lót trong lòng các xoang cạnh mũi.

Cơ chế: Phù nề niêm mạc -> Bít tắc lỗ thông xoang
-> Ứ đọng dịch nhầy -> Nhiễm khuẩn hình thành mủ.

1.2 Phân loại lâm sàng



Cấp tính: Kéo dài dưới 4 tuần.



Bán cấp: Từ 4 đến 12

tuần.

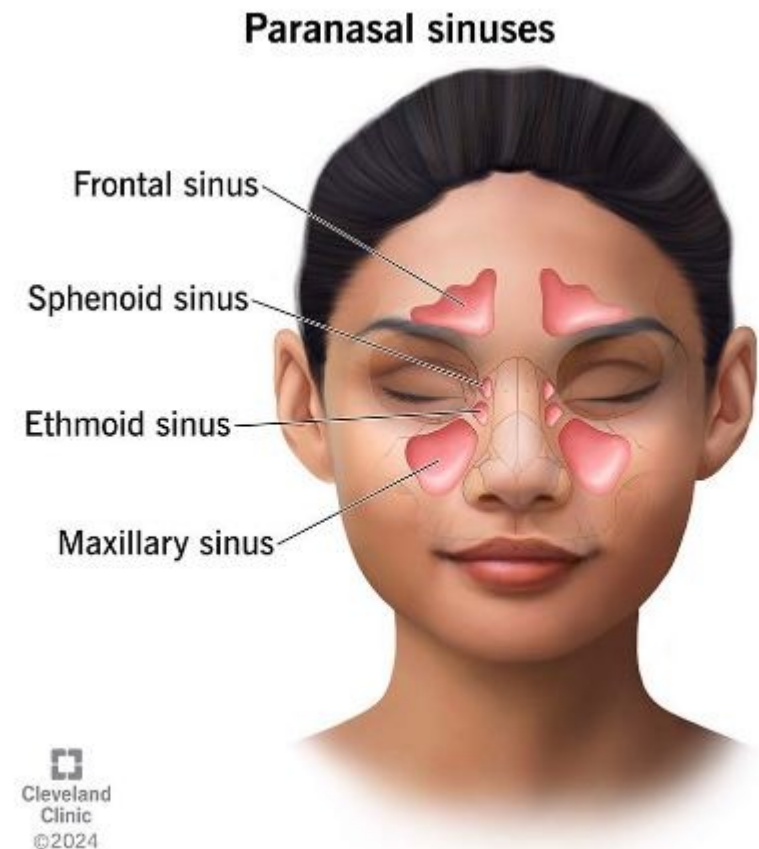


Mãn tính: Trên 12 tuần, dễ tái phát.

**Hệ thống xoang bao gồm: Xoang hàm (hay gộp nhất), xoang trán, xoang sàng và xoang bướm.*

2. NGUYÊN NHÂN & YẾU TỐ THUẬN LỢI

- 🦠 **Nhiễm khuẩn:** Tiếp nối sau viêm mũi cấp, cúm, sởi hoặc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên.
- 🫁 **Cơ địa dị ứng:** Dị ứng với thời tiết, phấn hoa, hóa chất làm niêm mạc mũi phù nề.
- 🕒 **Bất thường cấu trúc:** Lệch vách ngăn mũi, Polyp mũi gây cản trở dẫn lưu dịch.
- 🦷 **Do răng:** Sâu răng hàm trên (R5, R6, R7) lan trực tiếp vào xoang hàm.



3.1. TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG (CHỦ QUAN)

Đau nhức vùng mặt

Triệu chứng chính. Đau tăng khi cúi đầu, đau theo giờ (xoang trán đau nhiều lúc 10h sáng). Vị trí đau báo hiệu xoang viêm.

Chảy mũi mủ

Dịch vàng hoặc xanh đặc, mùi hôi. Chảy ra cửa mũi trước hoặc chảy xuống họng gây kích ứng gây ho.

Nghẹt mũi & Khó thở

Một hoặc hai bên, gây khó thở, mệt mỏi, ảnh hưởng giấc ngủ. NB thường phải thở bằng miệng.

Rối loạn khứu giác

Ngửi kém hoặc mất khả năng ngửi do dịch mủ che lấp vùng thần kinh khứu giác ở khe mũi trên.

3.2. TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ (KHÁM LÂM SÀNG)

 Hình ảnh nội soi mũi xoang có mủ

Điều dưỡng khám thấy:

-  **Soi mũi:** Niêm mạc mũi nề, sung huyết đỏ. Có mủ ở khe giữa hoặc khe trên.
-  **Ấn các điểm đau:** Đau chói khi ấn hố nanh (xoang hàm), hố mắt (xoang trán).
-  **Toàn thân:** Sốt nhẹ, mệt mỏi, môi khô, lưỡi bẩn do nhiễm trùng kéo dài.

4. BIẾN CHỨNG TIỀM TÀNG

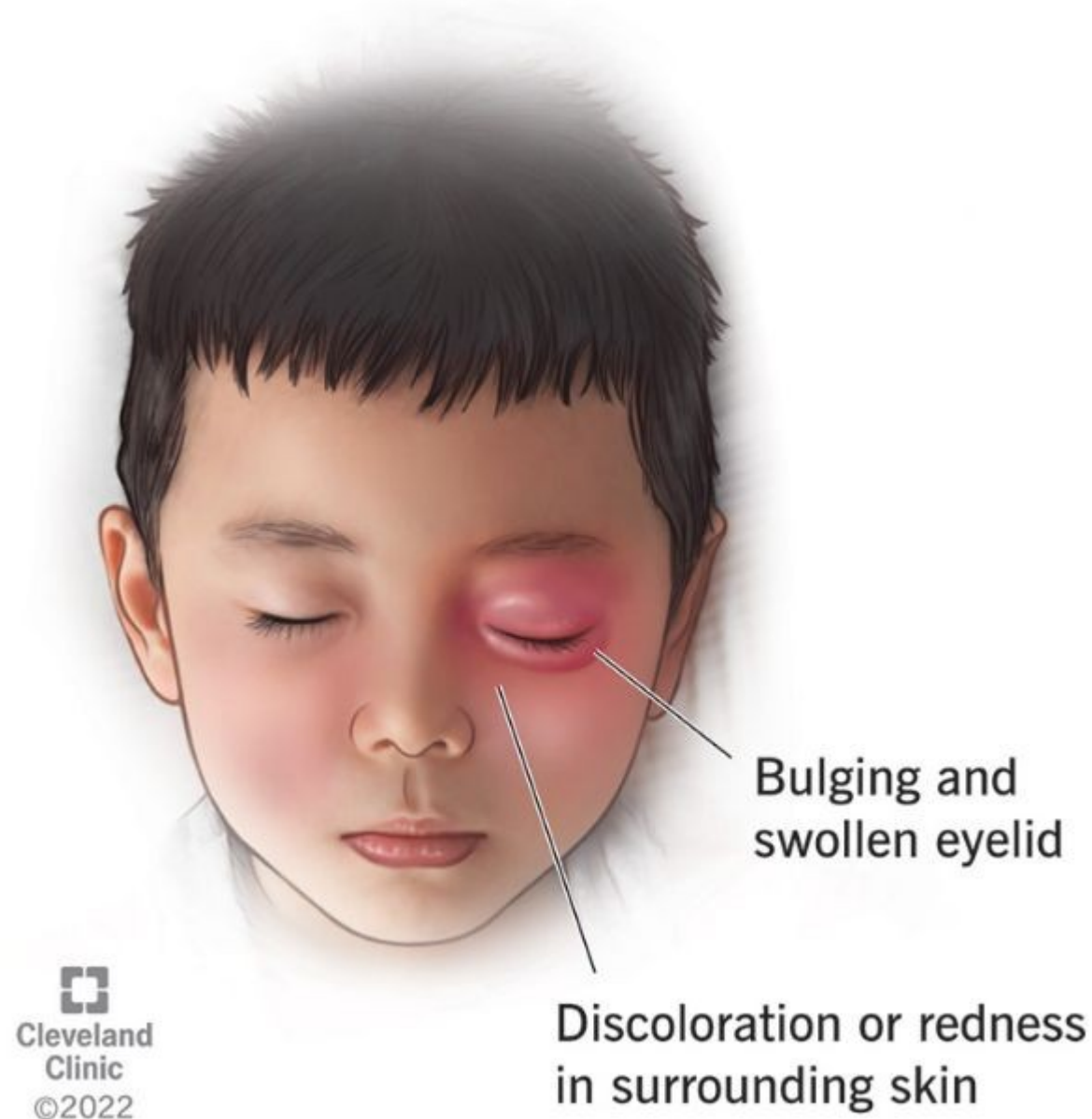
👁 **Biến chứng mắt:** Viêm mô tế bào ổ mắt, áp xe mí mắt, giảm thị lực (do xoang nằm sát hố mắt).

🧠 **Nội sọ:** Viêm màng não, áp xe não cực kỳ nguy hiểm.

Tai & Hô hấp: Viêm tai giữa, viêm họng mãn, viêm phế quản do mủ chảy xuống.

Dấu hiệu cảnh báo: Sốt cao đột ngột, lồi mắt, đau đầu dữ dội.

Orbital Cellulitis



5.1. NHẬN ĐỊNH ĐIỀU DƯỠNG

Bước nhận định	Chi tiết cần tập trung
Hỏi bệnh sử	Vị trí đau nhức? Thời gian đau trong ngày? Dịch mũi màu gì, có mùi hôi không? Có bị nghẹt mũi không?
Thăm khám	Quan sát vùng mặt có sưng nề không? Ấn các điểm xoang có đau không? Kiểm tra nhiệt độ và mạch.
Tiền sử & Kiến thức	Có bị dị ứng không? Có hút thuốc lá không? NB đã từng phẫu thuật mũi xoang chưa? Hiểu biết về cách vệ sinh mũi?

5.2. CHẨN ĐOÁN ĐIỀU DƯỠNG



Đau cấp tính vùng mặt và đầu liên quan đến quá trình nhiễm trùng và tắc nghẽn thông khí mũi xoang.



Tắc nghẽn thông khí mũi liên quan đến niêm mạc mũi phù nề và ứ đọng dịch mủ trong hốc mũi.



Nguy cơ biến chứng (mắt, sọ não) do người bệnh chưa tuân thủ điều trị hoặc chăm sóc vệ sinh mũi chưa đúng kỹ thuật.

5.3. THỰC HIỆN CHĂM SÓC

Chăm sóc tại chỗ



Vệ sinh mũi: Rửa mũi bằng NaCl 0.9%, hút mũi (nếu cần).



Xông mũi: Dùng tinh dầu hoặc thuốc theo y lệnh giúp loãng mũi.



Tư thế: Nằm đầu cao giúp dẫn lưu dịch mũi ra ngoài dễ hơn.

Thực hiện y lệnh



Cho uống kháng sinh, kháng viêm, giảm đau đúng liều,

đúng giờ.



Dùng thuốc co mạch (Naphtazolin, Xylometazolin) để

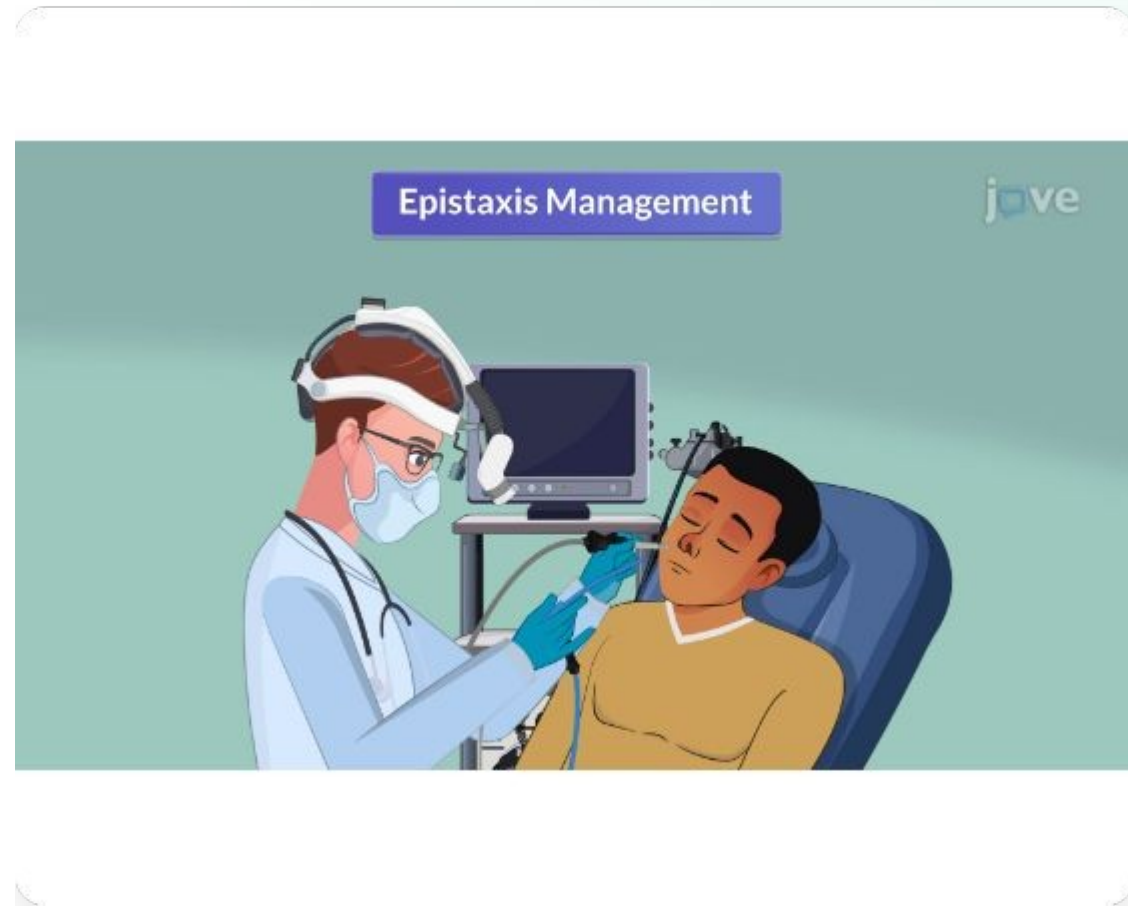


làm thoáng mũi.

Theo dõi tác dụng phụ của thuốc (khô mũi, nhịp tim nhanh).

6. GIÁO DỤC SỨC KHỎE & PHÒNG BỆNH

-  **Kỹ thuật xì mũi:** Bịt từng bên và xì nhẹ nhàng. Tuyệt đối không xì mạnh cả 2 bên cùng lúc (tránh đẩy mủ vào tai).
-  **Môi trường:** Đeo khẩu trang, tránh bụi, khói thuốc lá. Giữ ẩm vùng mũi cổ khi trời lạnh.
-  **Dinh dưỡng:** Uống nhiều nước (giúp loãng dịch), ăn uống đủ chất nâng cao đề kháng.
-  **Tái khám:** Đúng hẹn, không tự ý ngưng thuốc hoặc dùng thuốc nhỏ mũi quá 7 ngày.



CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Triệu chứng cơ năng nào giúp phân biệt rõ viêm xoang và viêm mũi thông thường?

A. Chảy mũi | B. Đau vùng mặt theo giờ | C. Nghẹt mũi | D. Hắt hơi

2. Kỹ thuật xì mũi đúng để tránh biến chứng viêm tai giữa là gì?

A. Xì thật mạnh | B. Bịt cả 2 bên | C. Bịt từng bên và xì nhẹ | D. Không được xì

3. Dung dịch ưu tiên để rửa mũi hàng ngày cho người bệnh viêm xoang?

A. Nước lã | B. NaCl 0.9% | C. Cồn 70 độ | D. Nước chanh

Đáp án: 1-B, 2-C, 3-B

XIN CẢM ƠN! —

Quý Thầy/Cô và các bạn có câu hỏi nào không?

**Sinh viên: Phạm Thị Bích
Hường**

Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk